LA BIENTRAITANCE
De quoi parle-t-on ?

UE D1.1 — Savoir-être, communication et leadership

IDÉE DIRECTRICE

La bientraitance ne se réduit pas à « être gentil ». Elle est une **façon de réfléchir et d'agir** qui tient compte de la personne, de ses besoins, de ses droits, de ses proches et des conditions réelles de soin.

Ce que l'enseignante souligne explicitement

• Comprendre la **philosophie de la bientraitance** plutôt que mémoriser mécaniquement chaque scène.

• Être capable de **définir la bientraitance** et de réfléchir à ce qui respecte ou non la personne.

• Identifier les **choix concrets** : écouter, adapter le soin, préserver l'autonomie et la dignité.

Priorités de révision déduites des situations analysées

• Analyser le rapport **bénéfices / risques** d'une décision.

• Reconnaître une **situation de vulnérabilité** sans effacer les capacités restantes.

• Différencier **acte technique** et **prendre soin** ; penser le travail en équipe.

FIL CONDUCTEUR

Observer la personne → rechercher ses besoins et ses préférences → expliquer et écouter → adapter sa façon de faire → réévaluer les effets.

01 Une philosophie active, pas un slogan

La bientraitance recherche le bien-être **physique et psychologique** de la personne soignée. Elle considère aussi les proches et les aidants. L'approche est centrée sur ce qui compte pour **cette personne précise**, et non sur les seules habitudes des professionnels.

Repère essentiel	Conséquence dans le soin
Ne pas nuire	Évaluer les effets indésirables possibles, y compris relationnels.
Maximiser les bénéfices possibles	Se demander ce que la décision apporte réellement au patient.
Limiter les dommages	Interroger douleur, contrainte, perte d'autonomie, atteinte à la dignité.
Reconnaître les droits et libertés	Écouter le refus, le consentement, les préférences et le vécu.

Exemple discuté : la contention physique

La formatrice propose l'hypothèse d'un patient agité en gériatrie, pour lequel une contention serait envisagée. Le **bénéfice supposé** serait de limiter une chute ; les **risques évoqués** concernent notamment la perte d'autonomie, la dignité, l'impossibilité de mouvements simples et la relation de confiance.

À RETENIR

Ce scénario sert à exercer un **raisonnement éthique bénéfices/risques**. Il ne constitue ni une indication de contention, ni un protocole clinique. Une mesure restrictive nécessite un cadre et une évaluation adaptés.

02 La personne avant l’organisation

Les besoins ne sont pas identiques d’un patient à l’autre. L’enseignante cite le récit d’une personne sévèrement paralysée qui accorde une grande valeur à des activités et liens simples : voir ses enfants, percevoir le lever du jour. **Ce qui semble secondaire au soignant peut être essentiel pour la personne.**

Question à se poser	Ce qu’elle change
Qui est cette personne ?	Considérer son histoire, ses goûts, son entourage et ses habitudes.
Quelles sont ses priorités ?	Demander ce qui compte pour elle, plutôt que décider à sa place.
Quelles capacités sont conservées ?	Accompagner sans faire systématiquement à sa place.
Comment comprend-elle et s’exprime-t-elle ?	Adapter les moyens de communication et le temps laissé à la réponse.

À RETENIR

La qualité d’un soin ne se mesure pas seulement à la réussite du geste : la **singularité**, le vécu et la possibilité de choisir font partie de l’accompagnement.

Une relation de confiance se construit aussi dans les petits actes du quotidien : regarder la personne, prendre en compte une demande et faire place à son ressenti.

03 Vulnérabilité et capacités restantes

Les trois scènes vidéo discutées présentent un enfant, une personne en situation de handicap et une personne âgée. Leur point commun identifié dans l'échange est la **vulnérabilité**, avec, selon les situations, une dépendance ou une difficulté à faire entendre ses besoins.

La vulnérabilité n'autorise ni l'infantilisation ni la mise à l'écart. Elle appelle au contraire une attention renforcée à la dignité, aux droits et aux moyens de communication.

Situation	Question professionnelle
Enfant ne pouvant pas tout verbaliser	Comment rechercher les signes de confort ou d'inconfort et adapter l'approche ?
Personne ayant besoin d'aide pour se mobiliser	Comment préserver les possibilités d'activité, de communication et de choix ?
Personne âgée isolée lors d'un repas	A-t-elle les moyens de manger, de choisir et d'échanger ?

POINT DE VIGILANCE

La définition de la vulnérabilité donnée dans la discussion est une **formulation pédagogique contextualisée**. Elle ne signifie pas que toute personne vulnérable serait incapable de décider : rechercher ses capacités et ses souhaits reste indispensable.

04 Soigner et prendre soin

L’enseignante oppose pédagogiquement une logique limitée à l’**exécution du geste** à une logique de **prendre soin** qui maintient la relation. La dimension technique et la dimension relationnelle sont complémentaires : l’une ne dispense pas de l’autre.

Approche centrée sur la tâche	Approche centrée sur la personne
Déposer un plateau et quitter la chambre.	Vérifier si la personne peut se nourrir et souhaite de l’aide.
Réaliser rapidement un prélèvement.	Écouter aussi ce que la personne exprime pendant le soin.
Assurer la toilette selon une routine.	Expliquer, respecter la pudeur et laisser participer.
Penser « le geste est fini ».	Évaluer la réaction et la compréhension de la personne.

Il est possible de prendre soin sans geste technique

Écouter, expliquer, jouer avec un enfant ou accompagner une personne dans une activité peuvent relever du prendre soin. Inversement, un soin technique devient aussi un temps de relation lorsqu’on y laisse une place à la parole et au vécu.

À RETENIR

Ne pas opposer « compétence technique » et « humanité ». L’enjeu est de les **articuler** dans la situation réelle, sans réduire le patient à une tâche à accomplir.

05 Les cinq principes énoncés dans la séance

L’enseignante relie la bientraitance à une culture partagée et propose cinq repères de respect à identifier dans les gestes du quotidien.

Principe formulé	Application possible
1. Respect de la personne et de son entourage	Considérer les besoins, les choix et la place de ses proches.
2. Respect de la dignité	Reconnaître la personne, sans la réduire à l’âge ou au handicap.
3. Respect de l’intimité	Préserver le corps découvert, la pudeur et les affaires personnelles.
4. Respect de l’autonomie	Favoriser ce qu’elle peut faire elle-même ; éviter de se substituer inutilement.
5. Sécurité physique et morale	Prévenir les dangers physiques et les situations d’isolement ou de dévalorisation.

À RETENIR

Une personne peut être **physiquement en sécurité** tout en se sentant humiliée ou mise à l’écart. La sécurité morale et la considération font partie du soin.

06 Trois scènes pour réfléchir au réajustement

L’analyse orale d’une vidéo met en regard un accompagnement essentiellement fonctionnel et des comportements plus attentifs aux particularités de chaque personne. Les scènes ci-dessous reprennent **ce qui a été discuté pendant la séance**.

Situation	Réajustements discutés
Enfant : vulnérabilité et besoin de réassurance.	Observer ses réactions ; laisser une place à un contact et à une approche adaptée.
Personne handicapée : position allongée, lunettes, besoin d’activité.	Considérer la mobilisation, l’accès à des activités, au regard et à la communication.
Personne âgée : plateau déposé de façon impersonnelle.	Accompagner l’alimentation et la relation, vérifier les besoins réels.

Méthode proposée pour chaque situation

- Décrire les **faits observés** sans attribuer une intention négative certaine.
- Proposer un **ressenti possible** de la personne, puis rechercher sa confirmation.
- Identifier un **ajustement concret** réalisable et son effet attendu.

ATTENTION

Les séquences vidéo ne sont pas disponibles dans les sources remises. Les exemples ci-dessus sont issus des **commentaires oraux**, et non d’une analyse directe des images.

07 Langage, intimité et consentement

Plusieurs scènes proposées par l’enseignante montrent que la posture relationnelle passe par des détails observables.

Comportement qui pose question	Pratique à privilégier
Entrer sans frapper et annoncer : « Je viens vous laver ».	Frapper, se présenter, expliquer l’aide à la toilette, demander l’accord.
Appeler systématiquement une personne « mamie ».	Utiliser une façon de s’adresser respectueuse et adaptée à ses préférences.
Parler dos tourné ou répondre à la place de la personne.	Rechercher son regard et lui laisser la parole, même si un proche est présent.
Exposer le corps en laissant la pièce ouverte ou froide.	Protéger l’intimité, la pudeur et le confort.
Juger une demande de rapprochement entre résidents âgés.	Respecter la vie affective et les choix, sans jugement lié à l’âge.

À RETENIR

Informer, écouter et rechercher le consentement ne sont pas des formalités à cocher : ils donnent une place réelle à la personne.

08 La bientraitance est aussi collective

Le soin ne dépend pas uniquement de la bonne volonté individuelle. L'enseignante évoque les contraintes de temps, les tournées, l'effectif et l'organisation. Ces éléments peuvent aider à **comprendre une situation sans excuser un manquement** envers la personne.

Niveau	Moyens discutés
Professionnel	S'interroger sur ses gestes, reconnaître une maladresse et chercher un ajustement.
Équipe	Partager les observations, transmissions, difficultés et projets adaptés.
Établissement	Organiser des conditions de travail compatibles avec une prise en soin respectueuse.
Projet de vie	En structure d'hébergement, prendre en compte les activités et préférences de la personne.

Situation discutée : le temps du repas

Un rythme imposé par l'organisation peut entrer en tension avec celui de la personne. L'enseignante invite à rechercher des adaptations collectives plutôt que de considérer l'horaire habituel comme intangible.

À RETENIR

La bientraitance est à la fois **une responsabilité personnelle** et **une culture d'équipe et d'institution**.

09 Analyser une situation professionnelle

Pour réviser, partir d’une situation et construire une réponse fondée sur les faits et les ajustements possibles.

Étape	Question à se poser
1. Observer	Que voit-on ou qu’entend-on réellement ?
2. Identifier	Quels besoins, droits ou capacités sont concernés ?
3. Nuancer	Quel effet possible sur le vécu, sans l’affirmer comme certain ?
4. Réajuster	Quelle action observable proposer ici et maintenant ?
5. Évaluer	Comment vérifier que l’action convient à la personne ?

Pièges QCM / confusions à éviter

• **Bientraitance ≠ simple absence de maltraitance :** elle implique des actions et une réflexion positive.

• **Geste techniquement correct ≠ soin pleinement adapté :** la relation compte aussi.

• **Vulnérabilité ≠ absence de choix :** préserver et rechercher les capacités restantes.

• **Faire plus vite ≠ toujours mieux soigner :** respecter le rythme et l’autonomie.

• **Contrainte organisationnelle ≠ justification automatique :** analyser et chercher des adaptations.

• **Ressenti supposé ≠ fait établi :** observer, questionner et rester prudent.

10 Synthèse générale — L’essentiel du cours

La bientraitance est une **culture de soins centrée sur la personne**. Elle interroge chaque décision à travers ses bénéfices, ses risques, le vécu de la personne et les conditions dans lesquelles le soin est effectué.

À connaître	À appliquer
Définir une posture bientraitante.	Respecter les besoins, choix, libertés, la dignité et l’entourage.
Identifier les cinq principes discutés.	Personne et entourage ; dignité ; intimité ; autonomie ; sécurité physique et morale.
Reconnaître la vulnérabilité.	Chercher les capacités restantes et les moyens de communication.
Articuler le technique et le relationnel.	Accompagner la personne, pas seulement effectuer le geste.
Comprendre le caractère collectif.	S’appuyer sur l’équipe, les transmissions et une organisation adaptée.
Construire un réajustement.	Faits → impact possible → action concrète → réévaluation.

MÉMO

Respecter — écouter — expliquer — demander — adapter — réévaluer.
La personne n’est jamais une simple succession d’actes : ses besoins, son histoire et ses choix doivent rester visibles.

11 Définitions et mots-clés

Lexique de révision en texte sélectionnable : termes mobilisés dans la séance.

Terme	Définition de révision
Bientraitance	Culture et démarche de soin visant un accompagnement respectueux, attentif aux besoins, droits et préférences de la personne.
Bienfaisance	Recherche d'un bénéfice pour la personne ; notion évoquée en lien avec la bientraitance.
Non-malfaisance	Principe consistant à chercher à ne pas nuire à la personne et à son entourage.
Bénéfice/risque	Mise en balance des effets positifs attendus et des dommages possibles d'une décision.
Dignité	Reconnaissance de la valeur de chaque personne et du respect qui lui est dû.
Intimité	Sphère corporelle et personnelle dont la protection participe au soin.
Autonomie	Capacité de la personne à agir et à faire des choix, à préserver autant que possible.
Vulnérabilité	Situation dans laquelle une personne peut être plus exposée à une atteinte à ses intérêts ou avoir des difficultés à les faire valoir.
Consentement	Accord recherché à partir d'une information adaptée et d'une possibilité d'expression.
Prendre soin	Accompagnement tenant compte des dimensions humaines et relationnelles, au-delà de la seule réalisation d'un acte.
Soin relationnel	Dimension du soin mobilisant présence, échange, écoute et adaptation.
Maltraitance	Atteinte possible à l'intégrité ou aux droits ; la séance rappelle aussi les dimensions institutionnelles.
Sécurité morale	Protection contre des atteintes relationnelles telles que l'humiliation ou l'isolement.
Transmission	Partage utile d'informations à l'équipe pour assurer une prise en soin adaptée.
Réajustement	Modification d'une pratique à partir d'une observation ou d'un retour de la personne.